

TEMA 5.2 • OFTALMOLOGÍA

ojo rojo superficial

PERFIL EUNACOM 6.02.1.005
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción al Ojo Rojo Superficial: Conjuntivitis

La clínica general de las conjuntivitis es un cuadro de **ojo rojo superficial** que puede acompañarse de ardor, "sensación de arenilla ocular", e hiperemia conjuntival generalizada, junto con un patrón característico de **secreción**.

- Existen tres tipos de conjuntivitis que son los más importantes en la práctica clínica:
- Conjuntivitis Bacteriana**
- Conjuntivitis Viral**
- Conjuntivitis Alérgica**
- Las diferencias más significativas entre ellas se dan en:
- Las características de la **secreción**.
- La presencia y tipo de **reacción palpebral o tarsal**.
- La presentación uni o bilateral, simétrica o asimétrica.

Diagnóstico Diferencial de Conjuntivitis

TABLA 5.2.1: CARACTERÍSTICA VS CONJUNTIVITIS BACTERIANA

CARACTERÍSTICA	CONJUNTIVITIS BACTERIANA	CONJUNTIVITIS VIRAL	CONJUNTIVITIS ALÉRGICA
Etiología típica	<i>Staphylococcus aureus</i> (más frecuente)	Adenovirus (más frecuente), Sarampión, Zika, COVID-19	Atopia, pólenes, alérgenos ambientales
Secreción	Purulenta (pus amarilla, muy abundante)	Serosa (o levemente mucosa)	Mucosa (o seromucosa)
Reacción tarsal	Sin reacción hipertrófica evidente (puede haber un leve edema/eritema)	Reacción de tipo Folicular (puntos solevantados pálidos)	Reacción de tipo Papilar (empedrado)
Amanecer	Ojos muy pegados con abundantes lagañas ("ojos sellados")	Ojos levemente pegados	Ojos levemente pegados
Cronología	Unilateral \$\\rightarrow\$ Bilateral (rápido, contagioso)	Unilateral inicial \$\\rightarrow\$ Bilateral a los 2-3 días	Usualmente Bilateral desde el inicio
Síntomas Extraoculares	Sistémicos raros (aislado al ojo)	Adenopatía preauricular , Fiebre, Faringitis (Fiebre Faringoconjuntival)	Prurito , Rinitis, Asma, estacionalidad

NOTA CLÍNICA

Tanto en la conjuntivitis viral como en la alérgica, **pueden** haber lagañas al despertar; sin embargo, cuando la cantidad es sumamente abundante y purulenta debiera orientarnos inmediatamente a una conjuntivitis bacteriana franca o una sobreinfección bacteriana.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **hiperemia** en la alergia suele ser bilateral, recurrente y asociada a la palabra mágica **Prurito**. Si te describen un ojo con sensación de arenilla y prurito, es **Conjuntivitis Alérgica**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **conjuntivitis papilar gigante** se puede ver en alergias severas, pero en la práctica moderna es casi siempre un indicio de **reacción al lente de contacto**. El tratamiento inmediato es la suspensión del uso de lentes de contacto y referir al oftalmólogo.

Tratamiento General de las Conjuntivitis

- Todas las conjuntivitis se benefician de algunas medidas de tipo general orientadas a mejorar los síntomas:
- No restregar los ojos**: el frote empeora y perpetúa la inflamación aguda.
- Lubricación**: instilar lágrimas artificiales de forma regular.
- Aseo ocular frecuente**: remover secreciones y costras con suero fisiológico o soluciones limpias.

Tratamientos Específicos por Etiología

1. Conjuntivitis Bacteriana

Aunque en un adulto sano puede ser autolimitada, se indica tratamiento activo por ser sumamente **contagiosa** (muy clásico en jardines infantiles y brotes intrafamiliares). - Se indican antibióticos que cubran cocos grampositivos (*S. aureus*). - **Posología**: 5 a 7 días. - **Gotas**: instilar cada 2 a 4 horas. - **Ungüentos**: preferidos en pediatría (el niño no coopera) o para su aplicación en la noche para mantener un efecto prolongado sin despertar al paciente. Se aplican cada 4 a 6 horas en niños pequeños. - **Bármacos más usados**: **Gentamicina** tópica, **Tobramicina** tópica (aminoglucósidos), y **Cloranfenicol** tópico. Alternativas: eritromicina, polimixina, cotrimoxazol.

2. Conjuntivitis Viral

Como su origen es vírico (comúnmente **Adenovirus**), la evolución es autolimitada a lo largo de los días. - **Manejo**: Tratamiento netamente sintomático. - Analgésicos y AINEs de uso sistémico (**Paracetamol**) para el manejo paralelo de la fiebre y el dolor faríngeo en la Fiebre Faringoconjuntival.

3. Conjuntivitis Alérgica

- **Fármacos de elección**: **Antihistamínicos tópicos** tales como **Azelastina** tópica, **Olopatadina** tópica o **Cetirizina** tópica.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¿Y los antihistamínicos orales (Loratadina)? Aunque son muy comunes y económicos para tratar las alergias sistémicas concomitantes (como rinitis alérgica), los antihistamínicos por boca **tienen riesgo intrínseco de generar ojo seco**. Por esta razón, si el oftalmólogo constata o el paciente desarrolla secuela de **ojo seco**, se deben retirar obligatoriamente los orales y manejar con formulaciones 100% de uso tópico en el ojo.

EUNACOM CRITERIOS

Regla de Oro sobre los Corticoides Tópicos El médico general o médico de urgencias **NO** debe recetar ni prescribir jamás medicamentos y colirios oftalmológicos que contengan **corticoides**. Su uso prolongado tiene fuertes riesgos vinculados a **Glaucoma Secundario** crónico ciego y cataratas agudas, o perforaciones oculares si la afección inicial resultaba ser herpética o micótica. Su receta es exclusiva del oftalmólogo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un estudiante universitario de veinte años consulta por ojo rojo derecho de un día de evolución con secreción acuosa y sensación de cuerpo extraño. Al examen se palpa una adenopatía preauricular derecha y se observa reacción folicular conjuntival. La agudeza visual es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para ojo rojo superficial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La conjuntivitis bacteriana se caracteriza por secreción purulenta abundante y legañas, tratamiento con antibióticos tópicos.
- La conjuntivitis viral es la más frecuente, se inicia unilateral y se hace bilateral en dos a tres días, la secreción es cerosa.
- La adenopatía preauricular palpable es el signo más característico de la conjuntivitis viral, el agente más frecuente es adenovirus.
- La conjuntivitis alérgica tiene como síntoma cardinal el prurito intenso, secreción mucosa y reacción papilar, es bilateral y estacional.
- La reacción folicular orienta a conjuntivitis viral; la reacción papilar orienta a conjuntivitis alérgica.
- El tratamiento difiere según el tipo: antibióticos tópicos en bacteriana, sintomático en viral, antihistamínicos tópicos en alérgica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OJO ROJO SUPERFICIAL)**PREGUNTA 1**

Un estudiante universitario de veinte años consulta por ojo rojo derecho de un día de evolución con secreción acuosa y sensación de cuerpo extraño. Al examen se palpa una adenopatía preauricular derecha y se observa reacción folicular conjuntival. La agudeza visual es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Conjuntivitis bacteriana por *Staphylococcus aureus*
- B)** Conjuntivitis alérgica estacional
- C)** Conjuntivitis viral por adenovirus
- D)** Queratitis herpética
- E)** Conjuntivitis gonocócica hiperaguda

PREGUNTA 2

Una mujer de treinta y cinco años con antecedente de rinitis alérgica consulta en primavera por ambos ojos rojos con prurito intenso de tres días de evolución. La secreción es escasa y mucosa. No hay adenopatía preauricular. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A)** Antibióticos tópicos como cloranfenicol
- B)** Antivirales tópicos como aciclovir
- C)** Antihistamínicos tópicos
- D)** Lubricantes oculares exclusivamente
- E)** Corticoides tópicos en dosis alta por un mes

PREGUNTA 3

Un paciente consulta por ojo rojo con secreción purulenta abundante que pega sus párpados al despertar. Al día siguiente refiere que el otro ojo también está rojo con la misma secreción. ¿Cuál de las siguientes características habría orientado más específicamente a una conjuntivitis viral en lugar de bacteriana?

- A)** Secreción purulenta bilateral abundante
- B)** Bilateralización en dos a tres días
- C)** Adenopatía preauricular palpable
- D)** Enrojecimiento conjuntival difuso
- E)** Ausencia de compromiso visual

RESUMEN: OJO ROJO SUPERFICIAL

Las conjuntivitis son la causa más frecuente de ojo rojo superficial y se clasifican en tres tipos principales: bacteriana, viral y alérgica. La conjuntivitis bacteriana se presenta con secreción purulenta o mucopurulenta abundante, las legañas características que pegan el ojo al despertar, y enrojecimiento difuso. El tratamiento es con antibióticos tópicos como el cloranfenicol. La conjuntivitis viral es la más frecuente de todas. Generalmente se inicia unilateral pero en dos a tres días se hace bilateral por autoinoculación. La secreción es cerosa o acuosa, se acompaña de reacción folicular a nivel conjuntival y adenopatía preauricular palpable, que es un signo muy característico. El agente más frecuente es el adenovirus. No tiene tratamiento específico más allá del manejo sintomático. La conjuntivitis alérgica en cambio se caracteriza por prurito ocular intenso como síntoma cardinal, secreción mucosa transparente y reacción papilar a nivel conjuntival, a diferencia de la folicular de las virales. Suele ser bilateral y estacional, relacionada con la exposición a alérgenos. El tratamiento son antihistamínicos tópicos y en casos más graves corticoides tópicos de corto plazo. Distinguir entre estos tres tipos es fundamental para el médico general ya que el manejo es completamente diferente. Los elementos diferenciales clave son el tipo de secreción, la presencia de adenopatía preauricular en la viral, el prurito en la alérgica y el carácter unilateral inicial de la viral.